

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	負壓引流(Jackson-Pratt)護理 Nursing Care of Jackson-Pratt Drainage				
編號	A31000-Q02-W-C12	制定者	SI 柯亦芳	公布日期	99 年 04 月 20 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	109 年 06 月 16 日
版本/總頁數	第 3.5 版/5 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 06 月 05 日

一、目的

護理人員能正確操作負壓引流技術。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）技術目的

1. 保持管路清潔，促進傷口之癒合及舒適。
2. 了解引流管出血及滲液情形及早期發現感染徵象。
3. 了解引流管有無固定完整是否滑脫。

（二）用物準備

1. 治療盤。
2. 量杯。
3. 消毒溶液：75%Alcohol 棉片。
4. 清潔手套一付。
5. 止血鉗一支（備用）。

（三）步驟及要點說明

步驟	說明
1. 隨時觀察病人之引流管量，引流管若沒有負壓功能（球脹起來）或引流量大於二分之一則需倒掉或將空氣排出維持負壓狀態。	負壓功能需依醫囑處理，如引流管全壓或半壓。

主題名稱	負壓引流(Jackson-Pratt)護理	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q02-W-C12	版本	第 3.5 版	頁碼/總頁數	2/5

步驟	說明
	
2. 辨識病人（至少二種以上方法），向病人及家屬解釋目的。	辨識方法請依照「A31000-Q02-W-A09 病人辨識作業作業標準」執行。
3. 洗手。	
4. 備妥用物，將用物拿至病人單位。	
5. 拉上床簾，露出引流管部分。	
6. 戴上手套。	
7. 將引流管反折或以止血鉗夾住病人端。	避免引流液回流。
8. 打開 Jackson-Pratt 引流蓋將引流液倒出，以 75% Alcohol 棉片消毒 Jackson-Pratt 引流出口後蓋回 Jackson-Pratt 引流蓋。	
9. 引流管保持負壓（若將引流管反折，則將引流管放直；若以止血鉗夾住引流管，請將止血鉗移除）。	引流液引流出來後（將 Jackson-Pratt 壓扁以為維持負壓狀態）。
10. 協助病人整理衣物及單位。	
11. 清潔，整理及補充用物。	
12. 工作後洗手。	
13. 記錄：傷口大小、顏色、組織情形；敷料滲出液的顏色、量及性質。	

（四）異常狀況處理說明

異常狀況	處理對策
錯置： 因負壓引流均為手術時醫師放置，錯置情況機率低。	1. 通知醫師，立即拔除。 2. 評估病人狀況，是否需做立即處理。 3. 評估病人是否有相關合併症。 4. 於 HIS 系統完成異常事件通報。
滑脫： 負壓引流管（包含自拔）可能原因：因病人意識不清、躁動、不適等因素造成滑脫或自拔，或不小心拉扯、膠布固定不佳或縫合線脫落引起。	1. 評估病人狀況，是否需做立即處理。 2. 通知醫師。 3. 評估負壓引流管是否重新放置。 4. 衛教病人或主要照顧者負壓引流管存放的必要性與重要性，並評估管路擺放的適當性，避免拉扯。 5. 評估約束的必要性。 6. 於 HIS 系統完成異常事件通報。
阻塞：	1. 先 milking 管路方式來處理，若仍無法

主題名稱	負壓引流(Jackson-Pratt)護理	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-C12	版本	第 3.5 版	頁碼/總頁數	3/5

異常狀況	處理對策
負壓引流管阻塞可能原因：血塊堵住、引流液太黏稠。	暢通，通知醫師評估是否需要重新置放。 2. 加強負壓引流管衛教：保持通暢勿反折或壓迫。
折曲： 負壓引流管可能折曲原因：翻身時壓到或未擺放好。	1. 保持通暢勿反折。 2. 注意接頭有無鬆脫。
拔錯： 可能原因為：未使用兩種以上方式執行病人辨識，造成拔錯負壓引流管。	1. 評估病人狀況，是否需做立即處理。 2. 通知醫師評估負壓引流管是否需重新放置。 3. 於 HIS 系統完成異常事件通報。
感染：放置處可能會出現紅腫熱痛、分泌物、發燒等情形。	1. 若發現病人有感染徵兆，評估病人狀況，是否需做立即處理。 2. 發現感染立即通知醫師，評估是否需要拔除。 3. 通知醫師，評估是否需抽血、做傷口細菌培養、抗生素使用等

（五）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

（略）

五、流程圖

（略）

六、參考資料

（略）

七、附件

（略）

主題名稱	負壓引流(Jackson-Pratt)護理	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-C12	版本	第 3.5 版	頁碼/總頁數	4/5

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
99.04.20	1.0	新制定。	99 年 04 月 20 日 通過護理部照護 標準委員會。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
100.04.06	2.1	修改說明內容。	100 年 04 月 06 日 通過護理部照護 標準委員會。
101.06.06.	2.2	增加步驟及要點說明與修辭。	101 年 06 月 06 日 通過護理部照護 標準委員會。
102.02.26	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度 臨時檢閱。	
103.06.03	3.1	說明（三）步驟及要點說明： 刪除：打開引流管後的三消改為以 75%Alcohol 棉 片消毒 Jackson-Pratt 引流出口後蓋回 Jackson-Pratt 引流蓋。	103 年 06 月 03 日 護理部照護標準 委員會通過。
104.06.02	3.2	1. 第三項第（二）目用物準備刪除消毒溶液： Tr.Iodine；改為~75%Alcohol 棉片。 2. 第三項第（四）目異常狀況處理說明刪除：病安 通報管路自拔/滑脫意外事件、填寫異常處置表及 病安通報；改為~於 HIS 系統完成異常事件通報。	104 年 06 月 02 日 護理部照護標準 委員會通過。
105.06.07	3.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
106.06.05	3.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.13	3.3	第三項第四目異常狀況處理說明，阻塞及感染的異 常狀況及處置對策修改。	107 年 06 月 13 日 護理長會議通過。
108.06.06	3.4	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第三目異常狀況處理說明：拔錯-處置對策 -2.通知醫師評估負壓引流管是否需重新放置。 3. 第三項第八日本辦法經委員會通過後公布實施， 改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布 實施。	108 年 06 月 06 日 照護標準組會議 通過；108 年 06 月 12 日護理長會 議通過；108 年 06 月 18 日督導會議 通過公布。

主題名稱	負壓引流(Jackson-Pratt)護理	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-C12	版本	第 3.5 版	頁碼/總頁數	5/5

修正日期	版本	修正說明	備註
109.06.16	3.5	1. 第三項第三目步驟及要點說明：步驟：1.隨時觀察病人之引流管量，引流管若沒有負壓功能（球脹起來）或引流量大於二分之一則需倒掉或將空氣排出維持負壓狀態。說明：刪除若引流管放至頭部則。 2. 第三項第四目異常狀況處理說明：錯置的處理對策新增 4.於 HIS 系統完成異常事件通報。	109 年 06 月 04 日照護標準組會議通過；109 年 06 月 10 日護理長會議通過；109 年 06 月 16 日督導會議通過公布。
110.07.08	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.06.02	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.06.08	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.04.30	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.06.05	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	